

Storia della Follia — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 02

Due paradigmi in eterna tensione: la follia come malattia del cervello vs. la follia come prodotto delle passioni e della vita. Tutto il resto è il viaggio tra i due.

I due paradigmi centrali

- **Gehirnpsychiatrie** (psichiatria del cervello): follia = danno organico del SNC
 - Esempio: Donizetti, distrutto dalla sifilide al terzo stadio (paralisi progressiva)
 - **Geistespsychiatrie** (psichiatria della mente): follia = risposta a violenza, trauma, costrizione
 - Esempio: Lucia di Lammermoor — inganno, tradimento, eccesso di passioni
 - **Comprensibilità** (Jaspers): la follia passionale è comprensibile (ci riconosciamo qualcosa); quella organica è incomprensibile
 - Questi due sguardi non appartengono solo al passato — sono ancora presenti nel dibattito clinico oggi
-

Evoluzione storica

Grecia e Ippocrate

- Grecia arcaica: follia = possessione divina
- **Ippocrate** (~460 a.C.): emancipa la follia dalla religione; introduce la **teoria degli umori**
 - 4 umori: bile nera (melanconico), sangue (sanguigno), flegma (flemmatico), bile gialla (collerico)

- Squilibrio degli umori = malattia
- I **fluidisti** portano avanti questa teoria per secoli
- **Empedocle**: equilibrio tra poli contrari (caldo/freddo)
- "Squilibrato" nel linguaggio quotidiano viene da qui

Medioevo e Rinascimento

- Medioevo: religione domina, nessuna novità medica
- 1500–1600: Mercuriale (catatonia), Weyer (allucinazioni visive; streghe e erbe psicoattive); prime localizzazioni cerebrali

1600–1800: l'uomo macchina

- "Homme Machine": l'uomo come organismo meccanico
- **De Lamettrie** (1747): *L'uomo macchina*
- **Pomme** (1760): "attacchi di nervi"
- **Cullen** (1777): conia il termine **nevrosi**
- **Beard** (XIX sec.): **nevrastenia** — il cervello come batteria scaricabile

Pinel: la svolta (fine XVIII sec.)

- Bicêtre 1793: libera i folli dalle catene (gesto simbolico, ma la rivoluzione è concettuale)
- Tesi centrale: follia ≠ (sempre) malattia del cervello; spesso nasce dalle passioni → è **guaribile**
- Quattro principi fondamentali:
 - **Guaribilità** → follia da passioni si cura
 - **Patoplastica** → la malattia si esprime in modo unico su ogni persona (stesso disturbo ≠ stessa persona)
 - **Parzialità della follia** → c'è sempre una parte sana; ci si rivolge a quella, non si attacca il delirio
 - **Trattamento morale** → cura via relazione e ascolto
- Conosce la storia del paziente è preconditione della cura
- **Esquirol** (allievo): follia passionale → curabile; follia organica → incurabile
 - Idiozia = condizione di nascita · Demenza = deterioramento

Il positivismo: organicismo trionfante (XIX sec.)

- **Griesinger** (1845): "le malattie psichiche sono malattie del cervello" → **Somatiker** vs. **Psychiker**
- **Moleschott**: "il pensiero sta al cervello come l'urina sta ai reni"
- **Morel** (1809–1873): teoria della **degenerazione**
 - Follia = involuzione evolutiva, progressiva e irreversibile (sull'onda di Darwin)
 - Inizia con il **delirio paranoico**: premessa non universale + autoriferimento → deduzione coerente internamente ma falsa alla base (es. *"chi tossisce mi sfotte"* — logico in sé, ma la premessa non vale universalmente)
 - Porta alla **demenza precoce**
- **Lombroso**: antropologia criminale, atavismo; ma anche attenzione alla biografia dei soggetti
- **Krafft-Ebing**: "cervello debole" che cede alla civiltà

Kraepelin: la mappa nosologica

- Sintomi come **segni** da classificare, non da ascoltare
- **Malattie esogene**: psicologiche (traumi) e somatiche (infezioni, pellagra, batteri)
- **Malattie endogene**:
 - **Psicosi maniaco-depressiva**: salta l'asse emotivo
 - Maniacale: attenzione dispersa, ideazione accelerata, ipermotilità
 - Depressiva: attenzione difficile, pensieri poveri, rallentamento motorio
 - **Demenza precoce**: salta l'unità interna del soggetto
 - Allucinazioni, pensiero disordinato, emozioni spente, abulia → Bleuler la chiamerà **schizofrenia** (1911)

Bleuler: la sintesi (1911)

- Rinomina la demenza precoce: **schizofrenia**
 - **Sintomi primari** (fondamentali): organici, subiti
 - **Sintomi secondari** (accessori): reazione psicologica del soggetto; variabili — dipendono dalla soggettività
 - Recupera il principio patoplastico di Pinel
-

La Pellagra come paradigma

- **3 D**: Dermatosi, Diarrea, Demenza (+Death in inglese)
 - Causa: **monofagismo maidico** — dieta di solo mais → carenza di vitamina B3 (niacina)
 - Malattia della povertà: chi ne era colpito finiva in manicomio
 - Morale: cause somatiche esterne → sintomi psichici gravi
-

Cargnello: l'ambiguità irriducibile

- Tensione fondamentale di chi lavora con la sofferenza mentale: "**essere con qualcuno**" vs. "**avere qualcosa di fronte**"
 - La clinica non risolve questa tensione — la abita
-

Da ricordare:

Gehirnpsychiatrie vs. Geistespsychiatrie — i due sguardi che non si sono mai pacificati.

Pinel: guaribilità · patoplastica · parzialità della follia · trattamento morale — quattro principi ancora attuali.

Kraepelin: esogene vs. endogene; psicosi maniaco-depressiva vs. demenza precoce (**schizofrenia** in Bleuler, 1911).

Delirio paranoico = premessa non universale + autoriferimento.